جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : ماجده مختار محمود عتابى

المحافظة : الجيزه **الحي / المدينة :** اوسيم **العنوان :** القيراطيين

رقم البطاقة : 25711112100961 **رقم التليفون :** 01092202023 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 24-10-2026

العمر(تاريخ الميلاد) : 11-11-1957 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**

التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام تصوير مقطعي للصدر والبطن والحوض بالصبغة [11129] **قسم العلاج :** الاورام

التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: ماجده مختار محمود عتابى
National ID: 25711112100961

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL EGYPT

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Contrast-enhanced CT of chest, abdomen and pelvis.

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

DKs ١٤٩٢٢



بطاقة تحقيق الشخصية

ماجده
مختار محمود عتابى
قرية القيراطين
مركز اوسيم - الجيزه

٢٥٧١١١٢١٠٠٩٦١

JE1510907



٢٠٢١/١٢ ٢٥٧١١١١٢١٠٠٩٦١

بدون عمل

انثى مسلمة ارملة

البطاقة سارية حتى ٢٠٢٨/١٢/١٣

١

National ID – Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]
Mammogram

الريادة للأشعة

Name:	Magda Mokhtar Mahmoud Atabi	Age :	65
Referred by:	Prof. Dr/ ...1	Date :	08/10/2026
Examination:	MAMMOGRAPHY		

BILATERAL SONO-MAMMOGRAPHY:

- Both breasts show normal size, shape, nipple, areola, skin and subcutaneous tissue thickness.
- Breast parenchyma shows scattered fibro-glandular tissue (ACR-B).
- The right breast show diffuse increased skin thickness with retroareolar hyper densities .
- No clusters of micro calcifications detected.

Complimentary sonography revealed:

- ***The right breast show***
  - ***Irregular hypo echoic lesion at 9 o'clock measures 16x15x13mm showing irregular outline and surrounding with echogenic fat , no internal vascularity associated with moderate peri areola subcutaneous edema .***
  - ***few suspicious right axillary lymph nodes , some of them show rounded shape , largest measures 7x6mm , others show loss of central hilum with preserved oval shape largest measure 11x7mm .***

  …… Sonographic features of right breast suspicious lesion associated with inflammatory carcinomatosis and suspicious lymph nodes (BIRADS V) …… for FNAC ..
- **The left breast show no solid or cystic breast masses.**
- Normal caliber of lactiferous ducts with no ectatic changes.
- No suspicious left axillary LNs.

Best regards,
Dr. Heba Mohamed

[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]
Mammogram

الريادة للأشعة

Name:	Magda Mokhtar Mahmoud Atabi	Age :	65
Referred by:	Prof. Dr/ ...1	Date :	08/10/2026
Examination:	MAMMOGRAPHY		

BILATERAL SONO-MAMMOGRAPHY:

- Both breasts show normal size, shape, nipple, areola, skin and subcutaneous tissue thickness.
- Breast parenchyma shows scattered fibro-glandular tissue (ACR-B).
- The right breast show diffuse increased skin thickness with retroareolar hyper densities .
- No clusters of micro calcifications detected.

Complimentary sonography revealed:

- ***The right breast show***
  - *Irregular hypo echoic lesion at 9 o'clock measures 16x15x13mm showing irregular outline and surrounding with echogenic fat , no internal vascularity associated with moderate peri areola subcutaneous edema .*
  - *few suspicious right axillary lymph nodes , some of them show rounded shape , largest measures 7x6mm , others show loss of central hilum with preserved oval shape largest measure 11x7mm .*

  ..... ***Sonographic features of right breast suspicious lesion associated with inflammatory carcinomatosis and suspicious lymph nodes (BIRADS V) ..... for FNAC ..***
- **The left breast show no solid or cystic breast masses.**
- Normal caliber of lactiferous ducts with no ectatic changes.
- No suspicious left axillary LNs.

Best regards,
Dr. Heba Mohamed

[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]
Pathology Report

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL
Gustave Roussy International-Egypt- Pathology Lab
جوستاف روسي انترناشونال – مصر معمل الباثولوجي
جوستاف روسي

Patient Name	**ماجده مختار محمود**	**Case No.**	**451352**
Sex/Age	**Female 68 Y**	**Patient No.**	**31211**
Registered Date	**13/10/2026 01:55:32 PM**	**Referred By Dr.**	**Interventional Radiology**
Validation Date	**21/10/2026 11:20:16 AM**	**Branch**	**Gustave Roussy**
Reporting Date	**21/10/2026 11:21:26 AM**	**Pathology No.**	

Pathology Report

Clinical Data: Right breast 9 o'clock mass (BIRADS 5).

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 13/10/2026, at 02:55 pm. Cold ischemia time is 20 seconds.

Gross Examination:
- Fragmented grey, white tissue cores, ranging in size between 0.3 cm & 1 cm long, totally submitted.

Technique:
- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for;
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination:
- **Histologic type:** Invasive lobular carcinoma (classic and pleomorphic)
- **Histologic grade: 2 (**differentiation 3, pleomorphism 2, mitosis 2)
- **LCIS:** Present.
- **DCIS:** Absent
- **Microcalcification:** Absent
- **Angioinvasion:** Absent
- **Perineural invasion:** Absent
- **Tumor infiltrating lymphocytes (TILs):** 10%

Results:
* IPT (All controls showed appropriate reactivity):
- ER: Strong nuclear reaction in 97% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Weak nuclear reaction in <1% of tumor cells (score 2/8).
- Her2: Faint incomplete membrane reaction in more than 10% of tumor cells (score 1+).
- Ki67%: 30%.

Conclusion:
Right breast mass, Tru-cut biopsy:
- Invasive lobular carcinoma, Grade 2.
IPT:

[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]
Pathology Report

Gustave Roussy International-Egypt- Pathology Lab
جوستاف روسي انترناشونال – مصر معمل الباثولوجي

Patient Name	**ماجده مختار محمود**	**Case No.**	**451352**
Sex/Age	**Female 68 Y**	**Patient No.**	**31211**
Registered Date	**13/10/2026 01:55:32 PM**	**Referred By Dr.**	**Interventional Radiology**
Validation Date	**21/10/2026 11:20:16 AM**	**Branch**	**Gustave Roussy**
Reporting Date	**21/10/2026 11:21:26 AM**	**Pathology No.**	

- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Negative (score 2/8).
- Her2: Low (score 1+).

- Ki67%: 30%.

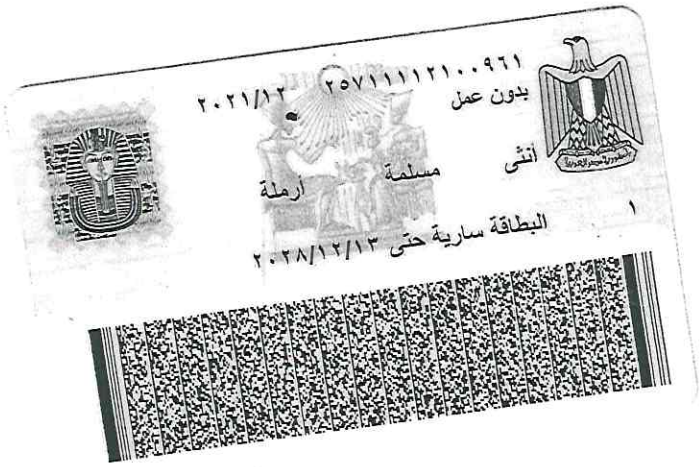
***Scoring system: "ER, PR"*
ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66%
and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, week, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.
** ***Scoring system: "Her2"***
Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendation. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0+ (Ultra-low) as defined by membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.
IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of
the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Signature
Dr. Hend El Ghareeb

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt



٠١٠٠٢٤٢١٩٠٠
٠١٠٩٢٢٠٠٢٣



National ID – Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

الريادة للأشعة

Name:	Magda Mokhtar Mahmoud Atabi	Age :	65
Referred by:	Prof. Dr/ ...1	Date :	08/10/2026
Examination:	MAMMOGRAPHY		

BILATERAL SONO-MAMMOGRAPHY:

- Both breasts show normal size, shape, nipple, areola, skin and subcutaneous tissue thickness.
- Breast parenchyma shows scattered fibro-glandular tissue (ACR-B).
- The right breast show diffuse increased skin thickness with retroareolar hyper densities .
- No clusters of micro calcifications detected.

Complimentary sonography revealed:

- ***The right breast show***
  - ***Irregular hypo echoic lesion at 9 o'clock measures 16x15x13mm showing irregular outline and surrounding with echogenic fat , no internal vascularity associated with moderate peri areola subcutaneous edema .***
  - ***few suspicious right axillary lymph nodes , some of them show rounded shape , largest measures 7x6mm , others show loss of central hilum with preserved oval shape largest measure 11x7mm .***

  ..... Sonographic features of right breast suspicious lesion associated with inflammatory carcinomatosis and suspicious lymph nodes (BIRADS V) ..... for FNAC ..

- **The left breast show no solid or cystic breast masses.**
- Normal caliber of lactiferous ducts with no ectatic changes.
- No suspicious left axillary LNs.

Best regards,
Dr. Heba Mohamed

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]